



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نجوى سمير عزمى بطرس

العنوان : 17 خ مساكن عبدالمنعم

المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : مدينه نصر الاول

رياض م الامل مدينة نصر اول- القاهرة

رقم البطاقة : 28503190102804 رقم التليفون : 01284566283 تاريخ تسجيل الإستمارة : 01-10-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 19-03-1985 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه التوقيع: (-----)

الإخصائي الاجتماعي التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : ----- التوقيع : -----
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : ----- التوقيع : -----
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : ----- التوقيع : -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة. تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / ----- أ.د. / ----- أ.د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : ----- قسم : -----
جهة العلاج : ----- نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نجوى سمير عزمي بطرس National ID: 28503190102804	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

٢٠٢٦/٠١ ٢٨٥.٣١٩.٠١.٢٨.٤

بدون عمل

أنثى مسيحية متزوجة

محسن حكيم عوض حنين

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٣/٠١/١٠

١



٠١٤٨٤٦٦٤٨٣

مار حبيب

رقم طلب العيلة

٢٠٧٤٨٠١٦٠

تابع الشغل ٨ ١١٩

فاقص الادارة

جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية

نجوى سمير عزمى بطرس

١٧ خ مساكن عبدالمنعم رياض - م الامل

مدينة نصر اول - القاهرة

٢٨٥.٣١٩.٠١.٢٨.٤

١٩٨٥/٠٣/١٨

L05593986



رقم التليفون: ٥٤٨٢٠١٣
الاسم: دكتور محمد لطفي التاريخ: ٢٠١٩ / ١٢ / ٢٥
الرقم القومي: ٥٥٥٦٧٨٩٠١٢٣٤

مستهدفة بالتوعية والإفصاح الأكاديمي

قياس ضغط	قياس السكر	العينات	مؤشر كتلة الجسم	الطول	الوزن
120/80	92	162	80		

*فكري نفسك باستمرار بموعد الفحص الذاتي شهرياً

	2025	مايو		2025	أبريل		مارس	2025
	2025	أغسطس		2025	يوليو		يونيو	2025
	2025	نوفمبر		2025	أكتوبر		سبتمبر	2025
	2026	فبراير		2026	يناير		ديسمبر	2025
	2026	مايو		2026	أبريل		مارس	2026
	2026	أغسطس		2026	يوليو		يونيو	2026
	2026	نوفمبر		2026	أكتوبر		سبتمبر	2026
	2027	فبراير		2027	يناير		ديسمبر	2026

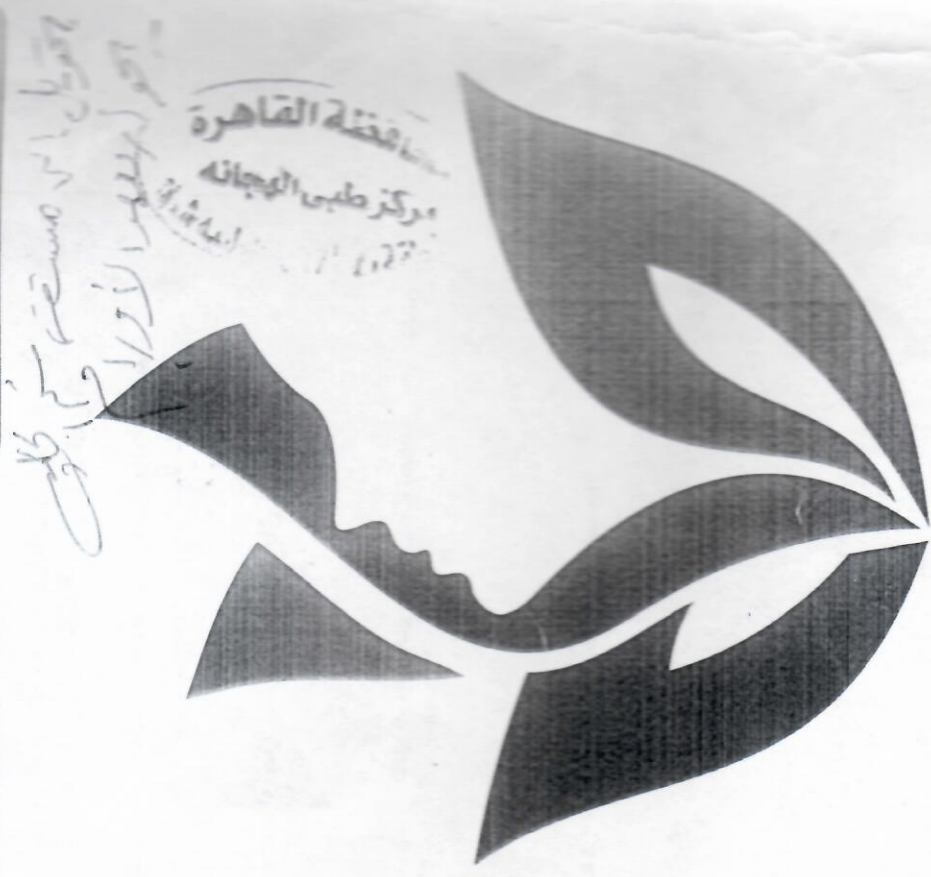
- حافظي علي قياس السكر والضغط مرة كل ٦ شهور.
- اذا كنتي في سن الزواج أو الإنجاب، إستشري بطبيب تنظيم الأسرة.
- اطمني، الكشف المبكر يساعد في السيطرة على الأمراض، وزيادة نسب الشفاء.

المكان المحولة له للتقييم:	توقيع الطبيب:
موعد الفحص القادم:	موعد التقييم:

المكان المحولة له للتقييم:

☎ 15335

www.100millionseha.eg



آرٹھ
ہجرت
مہاجر
مہاجر



جمهورية مصر العربية
منظمة الصحة العالمية



رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار : 2026-8-17

جهة الاصدار : فرع القاهرة

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة لانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسى " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى
والبحث تبين أن

السيد (ة) نجوى سمير عزمى بطرس بطاقة رقم 28503190102804
تليفون رقم: 01284566283

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعه : 2026-8-17

الموظف المختص

محمود عبدالله



افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 2052894



الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو
وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

اسم المريض بالإنجليزية: Nagwa Samir Azmi Buttros	كود المريض: 98539
تاريخ التقرير: 2026/08/18 10:16:38 AM	السن: ٤١ سنة ٣ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 42 years old female patient with right breast lump.

Detailed Findings

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The right breast shows posterior 1/3 large ill-defined spiculated dense mass lesion with obscured margins and architectural distortion
- Ultrasound revealed large ill defined hypoechoic mass lesion measures about 29x16mm at its maximum diameters and located at 6 ° o'clock position. The mass shows no clear line of cleavage with the underlying muscle suggestive of muscle invasion.
- Normal nipple/areolar complex.
- A solitary enlarged rounded axillary lymph nodes at level I with loss of hila, measures about 25x16 mm
- Few scattered subcentimetric cystic lesions .

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- Multiple small dispersed subcentimetric thin-walled anechoic cysts.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Right breast (BIRADS 5): Right posterior central malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary lymph node as described. For tru cut biopsy
- Left breast (BIRADS 2): left breast fibrocystic changes.

*Much obliged,
Dr. Marwa a. el seoud*

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

نجوى
سمير عزمى بطرس
خلف مساكين عبدالنعم رياض - الهجاءه
مدينة نصر اول - القاهرة

٢٨٥٠٣١٩٠١٠٢٨٠٤

١٩٨٥/١٠/٢٨

GF0374346

٢٨٥٠٣١٩٠١٠٢٨٠٤
٢٠١٥/٠٩

حصله على معتمد فنى تجارى

انثى مسيحية متروية
محسن حكيم عوض حنين
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/٠٩/٠٧

١



Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترنشنال - مصر عمل الباثولوجي



Patient Name	نجوى سيد عزمي	Case No.	359092
Sex/Age	Female 41 Y	Patient No.	26094
Registered Date	19/8/2026 10:54:18 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	24/9/2026 11:06:02 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	30/9/2026 10:45:27 AM	Pathology No.	2654/26

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 23/08/2026, Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

4 greyish, white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 2.0 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for,
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

-Histologic type: Invasive duct carcinoma with focal lobular differentiation.
- Histologic grade: 3 (differentiation 3, pleomorphism 3, mitosis 2)
- DCIS: Absent.
- Microcalcification: Absent.
- Angiolinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Moderate.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 85% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Moderate complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 2+).
- Ki67%:40%.
- SISH: Amplified (copy: 4.6, Ratio: 2.4).

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade 3, with focal lobular differentiation.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).



جوستاف روسي انترنشنال - مصر الباثولوجي - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Missr El Qadema - Cairo, Egypt



Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف رويسى القى نطو نال - مصر عمل الباثولوجى



Patient Name	نجوى سبى عربى	Case No.	359092
Sex/Age	Female 41 Y	Patient No.	26094
Registered Date	19/8/2026 10:54:18 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	24/9/2026 11:06:02 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	30/9/2026 10:45:27 AM	Pathology No.	2654/26

- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Equivocal (score 2+).
- Ki67%: 40%.
- SISH: Amplified (copy: 4.6, Ratio: 2.4).

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%; 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 1+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1++ as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.



عزقة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القنبية - القاهرة 3 - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Maser El Qadema - Cairo, Egypt

اسم المريض بالإنجليزية: Nagewa Samir Azmi Butros	كود المريض: 98539
تاريخ الفحص: 2026/08/18 10:16:38 AM	السن: 41 سنة 4 شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 42 years old female patient with right breast lump.

Detailed Findings

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- The right breast shows posterior 1/3 large ill-defined spiculated dense mass lesion with obscured margins and architectural distortion
- Ultrasound revealed large ill defined hypoechoic mass lesion measures about 29x16mm at its maximum diameters and located at 6 ° o'clock position. The mass shows no clear line of cleavage with the underlying muscle suggestive of muscle invasion. 
- Normal nipple/areolar complex.
- A solitary enlarged rounded axillary lymph nodes at level I with loss of hila, measures about 25x16 mm
- Few scattered subcentimetric cystic lesions .

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- Multiple small dispersed subcentimetric thin-walled anechoic cysts.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Right breast (BIRADS 5): Right posterior central malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary lymph node as described. For tru cut biopsy
- Left breast (BIRADS 2): left breast fibrocystic changes.

Much obliged,

Dr. Marwa a. el seoud

for Dynamic MRE breast!